

解剖學 醫學一

- 翼點 pterion 撞擊 → EDH (硬腦膜外血腫) → 破裂血管 = 腦膜中動脈 middle meningeal artery 113
- 視覺皮質 (枕葉) 血供 → 後大腦動脈 PCA 114
- 主動脈弓動脈瘤 → 聲音沙啞 → 壓迫左側喉返神經 (繞主動脈弓) 114
- 角膜反射 → 傳入 CN V (三叉脊髓核)、傳出 CN VII (顏面運動核) = 「5 入 7 出」 113
- 嗅覺 → 唯一不經丘腦的感覺 113

胚胎學 醫學一

- 嚼肌 (masseter) → 第一咽弓 (CN V)；第一弓也給 malleus/incus + 上下頷，第二弓 (CN VII) → stapes + 表情肌 反覆考
- 動脈導管 (左第六主動脈弓衍生) → 出生後閉鎖成 ligamentum arteriosum；左喉返神經繞其折返 反覆考
- 輸尿管芽 (ureteric bud) → 集尿系統 (輸尿管/腎盂/腎盞/集尿管)；後腎中胚層 → 鮑氏囊/近曲小管/腎絲球 反覆考
- Sertoli cell 分泌 MIS/AMH → 使副中腎管 (Müllerian duct) 退化；睪丸決定因子 (SRY/TDF) 在 Y 染色體 反覆考
- 脊索 (notochord) → 髓核 (nucleus pulposus)；生骨節 (sclerotome) → 椎體；軸旁中胚層 → 體節 常考

組織學 醫學一

- 製造睪固酮的細胞 → Leydig cell (萊迪氏細胞)；Sertoli cell 管 blood-testis barrier + 分泌 inhibin/AMH 反覆考
- 良性前列腺肥大 (BPH) 好發區 → 移行帶 (transitional zone)；前列腺癌好發周邊帶 (peripheral zone) 105-1
- CNS 具吞噬功能的膠細胞 → microglia (微膠細胞)；CNS 受傷由 microglia 清殘骸 + astrocyte 形成 glial scar (PNS 靠單核球衍生 macrophage) 反覆考
- 潘氏細胞 (Paneth cell, 含 lysozyme) → 小腸腸腺特有 (大腸無)；壁細胞屬胃腺 (不在腸腺) 反覆考
- 平滑肌無 T-tubule → 靠 caveolae 小凹運鈣；閥盤 (intercalated disc) 為心肌特有；gap junction 見於心肌+平滑肌 反覆考

生理學 醫學一

- 抑制 FSH 但不影響 LH → inhibin B (支持/顆粒細胞分泌) 115
- 檢測腎上腺皮質功能最具代表性的血中激素 → cortisol (終產物；ACTH/CRH 是上游不算) 113
- aldosterone 分泌部位 → zona glomerulosa (腎上腺皮質最外層) 112
- 高血糖+高血壓+皮膚色素沉積 → 腦下腺瘤大量分泌 ACTH (ACTH 與 MSH 同源) 114
- 低鈉(120)+高鉀(6.7) → adrenal insufficiency (醛固酮缺乏，無法留鈉排鉀) 112

生物化學 醫學一

- 嬰兒 lactate ↑ + pyruvate ↑ + alanine ↑ + 代謝性酸中毒 → 補 thiamine (維生素B1) (丙酮酸脫氫酶 PDH 的 E1 輔酶) 常青必掃
- 牙齦浮腫出血、傷口難癒 → 維生素C 缺乏 (壞血病)；C 缺 → proline hydroxylation 受阻 → collagen 修飾不全 死背送分
- DNA 大量損傷 → SOS response → RecA 促 LexA 自體裂解 (self-cleavage) 解除抑制 (RecA 非 protease，走 coprotease activity) 考多次
- 嘌呤分解終產物 = 尿酸 (uric acid)；嘧啶分解 → β-alanine (C/U) 或 β-aminoisobutyrate (T) 反覆考
- Adenosine deaminase (ADA) 缺乏 → 嚴重複合型免疫缺陷 (SCID)；orotic aciduria 補 uridine 治療 常青必掃

微生物學 醫學二

- 細菌最主要毒力因子 (抗吞噬) → 多醣莢膜 (polysaccharide capsule)；淚液的 lysozyme 可分解 peptidoglycan 反覆考
- 炭疽 EF + 霍亂毒素 + 百日咳毒素 → 共同點 升高細胞內 cAMP (ETEC 熱穩定毒素則走 cGMP) 反覆考
- HBV = 部分雙股環狀 DNA，卻靠 反轉錄酶經 RNA 中間體複製 (核內形成 cccDNA)；HAV/HEV 糞口傳染，HBV/HCV 易慢性化 反覆考
- HIV 共受器：M-tropic 用 CCR5、T-tropic 用 CXCR4；CCR5-Δ32 同合子 → 抗 HIV；主要感染 CD4 T (非 B 細胞) 反覆考
- 抗黴菌機轉：azole 抑 ergosterol 合成、echinocandin 抑 β-1,3-glucan (細胞壁)、griseofulvin 破壞微管、terbinafine 抑 squalene epoxidase、flucytosine 抑核酸 反覆考

免疫學 醫學二

- 四型過敏反應 → I=IgE/mast cell(過敏性鼻結膜炎、氣喘)；II=抗體對細胞抗原(免疫性血小板缺乏症)；III=免疫複合體(血清病)；IV=T細胞/Th1(接觸性皮炎) 反覆考
- IgM → B細胞活化後最早分泌的抗體 113反覆
- 活化補體最主要抗體 → IgM (非IgE)；活化mast cell最主要 → IgE (非IgG)；過胎盤 → IgG (非IgA) 113
- MLR / 移植前相容 → 評估 HLA-DR (MHC class II，測CD4 T增生) 115
- Class switch 需要 → AID + CD40 + CD40L (RAG1/ADA 不是) 115

寄生蟲學 醫學二

- P. vivax → 侵網狀紅血球、附著 Duffy 抗原；西非 Duffy 陰性故少見 反覆考
- 肝內 hypnozoites → 僅 vivax/ovale (knowlesi 無)
- Toxocara canis → 內臟/眼幼蟲移行症 + 肝腫大 + eosinophilia
- Angiostrongylus cantonensis → 食蝸牛→嗜伊紅性腦膜炎，CSF 找蟲確診
- 神經性囊尾幼蟲症 → 豬肉條蟲 Taenia solium (自體感染/食蟲卵)

公共衛生學 醫學二

- 型一錯誤 α = 棄真 (H₀ 對卻推翻)；型二錯誤 β = 存偽 (H₀ 錯卻不推翻)；power = 1-β (不是 1-α，兩者不會同時發生) 反覆考
- OR / RR / HR 的 95% CI → 不跨過「1」才達顯著；迴歸係數 β 與風險差則看 CI 不跨「0」 反覆考
- 統計方法選擇：同組前後測 → paired t-test；兩獨立組 → independent t-test；≥3 組平均 → one-way ANOVA；兩類別變項 → 卡方 (格數過少 → Fisher exact) 反覆考
- 健康工人效應 (healthy worker effect) → 選擇偏差 (selection bias，世代研究)；病例對照研究最大缺點 = 回憶偏差 (recall bias) 反覆考
- 三段五級預防：健康促進 (天天5蔬果) =初段一級；特殊保護=一段二級；早篩早治=次段三級；限制殘障=三段四級；復健=三段五級 反覆考

藥理學 醫學二

- 5-FU 機制 → 代謝成 FdUMP 抑制 thymidylate synthase 考兩次·超大重點
- Aspirin + 小兒病毒感染 → Reye syndrome；退燒首選 acetaminophen 104-114 反覆
- Warfarin 代謝基因 → CYP2C9 + VKORC1 (非 2C19) 死背送分
- Simvastatin → 抑制 HMG-CoA reductase；ezetimibe = NPC1L1、fibrate = PPAR-α
- Bleomycin → 打斷 DNA 生自由基；主要毒性 肺纖維化 愛考副作用

病理學 醫學二

- HPV 16/18 致子宮頸癌 → E6 抑制 p53、E7 抑制 Rb/p21 (與 BRCA 無關) 反覆考
- 免疫低下 + 去髓鞘 + 玻璃狀核內包涵體 + 巨大怪異星狀膠細胞 → 進行性多灶性白質腦病 PML (JC virus 感染 oligodendrocyte) 105-2
- 中年女性 + 搔癢黃疸 + 肝內小膽管破壞 + 非乾酪肉芽腫 → 原發性膽汁性膽管炎，抗粒線體抗體 (AMA) 陽性 106-1
- Type II 過敏 = 自體免疫溶血性貧血 + 急性風濕熱；Type III (免疫複合體) = SLE + 鏈球菌後腎絲球腎炎 反覆考
- 完全性葡萄胎 = 全父源、46,XX/XY、絨毛膜癌風險較高；不完全性 = 三倍體 (69,XXY)、癌變風險低 反覆考